

י"ט באדר תשפ"ב
20 בפברואר 2022

הצעה לשינויים בחוק הסיעוד מגמלה כספית לתמריץ לשירותים קהילתיים

שלוש שנים חלפו מאז נכנסה לתוקפה הרפורמה בחוק הסיעוד. בתקופה זו נלמדו הלקחים מהשינוי ומסתבר שבצד הברכה שבשינוי, שעיקרה תוספת שעות טיפול, יש גם כשלים שמטרת הצעה זו באה לתקנם. הרפורמה יצרה שינוי משמעותי בכל הנוגע לאפשרות של המרת חלק ניכר מהגמלה מגמלת שירותים לגמלה בכסף.

מטרת חוק הסיעוד היא לסייע לאזרחים הוותיקים שזקוקים לעזרת הזולת בביצוע כל או רוב פעולות היומיום שלהם (ADL). מתוך המידע שמגיע מהשדה מתברר שבמקרים רבים אלו שהמירו את הגמלה לגמלה בכסף לא השתמשו בכסף בכדי לטפל בזקן הסיעודי, דבר שגרם נזק לזקן הסיעודי וירידה בתפקודו.

מאז הרפורמה של 2018 חל גידול דרמטי במספר הזכאים לגמלת הסיעוד. בדצמבר 2021 עמד מספר הזכאים על 286,000 לעומת 180,000 בשנת 2018, דהיינו בשלוש שנים גדל מספר הזכאים בהיקף הגידול שהיה בעשרים השנים שקדמו לכך. תקציב גמלת הסיעוד גדל מ-7 מיליארד ל-13 מיליארד שקל.

מעל 70% מהזכאים ברמה הראשונה מקבלים את יח' הסיעוד בכסף בלבד וללא טיפול כלל (1,408 ש"ח) לפי 100% מערך הגמלה. כשליש מהזכאים ברמות 2-6 מקבלים את 4 היחידות הראשונות בכסף לפי ערך של 80%. כרבע מהזכאים ברמות 3-6 מקבלים שלוש מהגמלה בכסף. מבט היסטורי על המעבר מגמלה בעין לגמלה בכסף מצביע על נטייה הולכת וגוברת של מעבר לגמלה בכסף. לדוגמא, מספר האנשים שלקחו 4 יחידות בגמלה בכסף ברמות 2-6 גדל מ-22,407 בינואר 2019 ל-89,000 בדצמבר 2021.

המסקנה הברורה מכך היא שהשינוי שאפשר המרה רחבה של גמלת הסיעוד משירותים לגמלה כספית היה הגורם העיקרי לשינוי הדרמטי. אין כל ראייה לכך שהשינוי הביא לשיפור בטיפול ובאיכות החיים של הזקנים הסיעודיים, להיפך, יש מקום לשער שהמעבר לגמלה כספית אך גרם לכך שחלק ניכר לא זכה לטיפול הראוי וחלה הידרדרות במצבו. יתכן שהעלייה הדרמטית במספר הזכאים נובעת גם כתוצאה מהשינוי משלוש לשש רמות ומשינויים בנהלים לקבלת הסיוע, אך כל זאת עדיין מחייב מחקר ובדיקה מעמיקה, דבר שלא נעשה עד כה.

בכדי לשמור ולשפר את התפקוד של הזקנים הסיעודיים יש לדאוג ולהבטיח שיקבלו את הסיוע הנדרש. הדרך המובטחת להשגת יעד זה הוא בהכוונת הזקנים הסיעודיים לקבלת סיוע בבית ובקהילה. המדיניות של העדפת השירות בבית ובקהילה כבר הוכחה במחקרים רבים ומדיניות זאת אומצה על ידי כל המדינות בעולם. על בסיס זה נחקק חוק ביטוח סיעוד. כיום ישנו מערך רחב ומגוון של שירותים בקהילה ובנוסף למרכזי היום קיימים מועדוני מופת, מועדונים חברתיים, בתים חמים ועובדים סוציאליים מיוחדים לטיפול באזרחים וותיקים בקהילה. כל אלו מאפשרים הרחבת והתאמת השירות המתאים.

בישראל זכינו לפיתוח רחב ביותר של השירותים בבית ובקהילה, כאשר חוק ביטוח סיעוד הוא מהגורמים העיקריים. החוק נחקק כשירות בעין כי עמדת המחוקק הייתה שרק בדרך זו אפשר יהיה להבטיח לזקן הסיעודי את העזרה שהוא נזקק לה. פתיחת האפשרות להמרת הגמלה לגמלה כספית היא סטיה מפורשת מהמחשבה המקורית ומעקרונות היסוד של חוק ביטוח סיעוד.

במהלך השנים נוספה לסל השירותים האפשרות להמרת הגמלה בביקור במרכז יום ובהתחברות לקהילה תומכת. מהלך זה בוצע בכדי להרחיב את האפשרות של הזקן הסיעודי ליהנות משירותים נוספים בקהילה שעשויים לשפר את איכות חייו ולמנוע הידרדרות. קיימים בארץ 180 מרכזי יום ו-320 קהילות תומכות. לצערנו רק כ-3%

הועד המנהל:

פרופ' בריק יצחק - יו"ר

ד"ר נ. בלום

ד"ר י. בנבנישתי

ד"ר א. בר

ד"ר ל. בר טור

גבי י. גת

ד"ר י. זילברשג

פרופ' ר. חלאילה

גבי מ.ע. יעקבסון

ד"ר ב. כגנסקי

ד"ר ג. להמן

מר י. למברגר – מזכיר

ד"ר י. מערבי

ד"ר ס. נעים

ד"ר ש. קוניץ

מר א. קלמן

מר א. קפלון

ד"ר א. קפלון

מר גרי רוט

ד"ר ד. שגיא

גבי ט. שטרית

מר י. קפלון – גזבר

יו"ר קודם:

פרופ' ישראל (איסי) דורון

פרופ' י. פלגי -

עורך כתב העת

"גרונטולוגיה

וגריאטריה"

עו"ד ח. פרידמן

יועצת משפטית

מר מ. טולדו

יו"ר ועדת ביקורת

מר ר. ארניה, מר א.

רוטשטיין - חברי ועדת

ביקורת

גבי ר. לוי

מינהלנית

הועד המנהל:

פרופ' בריק יצחק - יו"ר

ד"ר נ. בלום

ד"ר י. בנבנישתי

ד"ר א. בר

ד"ר ל. בר טור

גב' י. גת

ד"ר י. זילברשלאג

פרופ' ר. חלאילה

גב' מ.ע. יעקבסון

ד"ר ב. כגנסקי

ד"ר ג. להמן

מר י. למברגר – מזכיר

ד"ר י. מערבי

ד"ר ס. נעים

ד"ר ש. קוניץ

מר א. קלמן

מר א. קפלון

ד"ר א. קפלון

מר גרי רוט

ד"ר ד. שגיא

גב' ט. שטרית

מר י. קפלון – גזבר

יו"ר קודם:

פרופ' ישראל (איסי) דורון

פרופ' י. פלגי -

עורך כתב העת

"גרונטולוגיה

וגריאטריה"

עו"ד ח. פרידמן

יועצת משפטית

מר מ. טולדו

יו"ר ועדת ביקורת

מר ר. ארניה, מר א.

רוטשטיין - חברי ועדת

ביקורת

גב' ר. לוי

מינהלנית

מזכאי חוק סיעוד מבקרים במרכזי היום, גם ההצטרפות לקהילות תומכות מצומצמות. שירות בעין, דהיינו טיפול בית, ביקור במרכז יום וקהילה תומכת, מאפשרים קשר שוטף עם הזקן ומיקוד הסיוע בהתאם לצרכיו ומצבו האישי.

גמלה בעין מאפשרת קשר השוטף ומעקב בלתי אמצעי בין המערכת הכוללת את משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וארגוני נותני השירותים לבין הזקן ומשפחתו. מערכת פיקוח, תהיה טובה ככל האפשר, לא יכולה להחליף את המגע האישי של המטפלים הישירים.

המהלך הנדרש כעת הוא לשנות את המגמה שפותחה מאז הרפורמה בשנת 2018, לצמצם את האפשרות להמרת גמלת הסיעוד לגמלה כספית וליצור תמריצים לשימוש בשירותים בקהילה.

המהלך הראשון המתבקש הוא שינוי לגבי רמה אחת בחוק הסיעוד. כיום כ- 76% מהזכאים ברמה אחת לוקחים את הגמלה הכספית בסך 1,408 שקל. יש עדויות לא מעטות על כך ששכום זה מצטרף להכנסת המשפחה ולא משמש לעזרה לזקן הסיעודי. אוכלוסייה זו, ברמת התפקוד הקלה יותר היא זו שיכולה ליהנות בצורה היעילה ביותר מהשירותים בקהילה ובמיוחד ממרכזי היום והקהילות התומכות. על פניו מובן שבעלות של שתי שעות טיפול יש תועלת רבה יותר בהשגחה של יום במרכז יום, הכולל הסעות, ארוחות פעילות חברתית ותעסוקתית. אי לכך יש ליצור תמריץ לשימוש במרכזי יום ובקהילות תומכות בצד הקטנת התועלת שבהמרת הגמלה לגמלה כספית.

במקום ההסדר הקיים של המרת שתי שעות טיפול בית ביום ביקור במרכז יום, מוצע לקבוע המרה של שעה אחת בלבד עבור ביקור במרכז יום. במקביל לכך במקום האפשרות להמיר 100% של המלגה לכסף לאפשר רק 50%. מהלך זה יביא לכך שיותר זקנים יבקרו במרכזי היום, יטופלו כראוי ולא זו בלבד שתמנע הידרדרותם התפקודית אלא תהיה בכך תרומה להפגת הבדידות שלהם, שימור תפקודם ושיפור איכות חייהם.

יש לראות במהלך זה רק צעד ראשון לשינויים המתבקשים בחוק הסיעוד. בהמשך לכך יש להמשיך ולצמצם את האפשרות להמרת הגמלה לגמלה כספית על ידי הקטנת אחוז ההמרה גם בשאר הרמות.

נייר עמדה זה מתייחס בעיקר לסוגייה המרכזית של **גמלה כספית אל מול גמלה בעין**. אולם, לאחר 35 שנים של קיום חוק הסיעוד, לדעתנו יש צורך בהערכה מקיפה וכוללת. בכלל זה יש להתייחס למצב **המטפלות** המהוות הגורם המרכזי במתן שירותי החוק. יש לבחון את תנאי עבודתם, מעמדם וההכשרה שלהם. בהקשר זה יש צורך גם בבחינת הנושא של **העובדים הזרים** (לא רק דרכי העסקתם). יש לתת את הדעת על **המטפלים הראשוניים** שהם לרוב בני משפחה הנושאים בעיקר הנטל של הטיפול בזקן הסיעודי. יש לארגן מחדש את מערך **הפיקוח והבקרה**, יש לשלב **מדדי איכות** להערכת השינויים בתפקוד של הזקן הסיעודי. אנו מציעים להקים וועדה ציבורית לבחינת כל ההיבטים של חוק הסיעוד על בסיס הנתונים הקיימים ומחקר של ההיבטים אשר עדיין לא נחקרו.

לסיום, חוק ביטח סיעוד הוא אחד מחוקי הרווחה המתקדמים והחשובים מבין שירותי הרווחה בישראל. יש לראות בו חלק אינטגרלי של מדיניות הרווחה בכלל ושל שירותי הרווחה לאזרחים הוותיקים בפרט.

פרופסור יצחק בריק



יו"ר האגודה הישראלית לגרונטולוגיה